Processo nº 0025877-31.2025.8.17.2001

AUTOR(A): C. F. A., C. F. A.

RÉU: UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS** ajuizada por **C. F. A.** (ID 198888549) e **C. F. A.** (ID 198888550), menores impúberes representadas por sua genitora FERNANDA FELÍCIO MATHIAS DA SILVA, através de advogado constituído (ID 198888540), em face de **UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, CNPJ nº **08.380.701/0001-05.**

À saída, a parte autora pugna pela: **(1)** tramitação prioritária do feito, com base no art. 152, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); **(2)** concessão do benefício da justiça gratuita, com base no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015); e **(3)** adesão ao Juízo 100% Digital, informando contato para eventuais diligências (valdeniofigueiredo@gmail.com (mailto:valdeniofigueiredo@gmail.com)). Além disso, informa desinteresse na realização de audiência de conciliação.

Alegam as autoras, em síntese, que são beneficiárias do plano de saúde na modalidade "individual ou familiar", categoria "UNIPLANO XII", conforme carteiras dos planos de saúde (IDs 198888544 a 198888548), e que obtiveram diagnóstico de Puberdade Precoce Central (CID E22.8), consoante laudos médicos expedidos pela Dra. Karla Pontes (endocrinologista pediátrica), CRM-PE 24.289 (ID's 198888573 e 198888574), havendo indicação de bloqueio hormonal com análogo de GNRH, LEUPRORRELINA 3,75MG, IM, a cada 28 dias, cuja aplicação deve ser realizada por profissional habilitado.

Informam que o tratamento foi considerado urgente pela médica assistente, tendo como objetivo evitar a progressão da idade óssea, preservando a estatura prevista para as pacientes, além de evitar danos psicológicos e sociais decorrentes da puberdade precoce não tratada.

Afirmam que a operadora de planos de saúde (OPS) demandada negou o fornecimento do medicamento, sob a justificativa de que ele não se enquadra como de uso ambulatorial, estando fora das hipóteses de cobertura obrigatória, conforme documento de ID 198888577.

Relatam que iniciaram o tratamento por conta própria, antes mesmo da negativa da operadora, e que o custo elevado da medicação comprometeu significativamente o orçamento familiar, somando os custos com o tratamento a importância de R$ 3.848,60, conforme notas fiscais anexadas aos autos (ID's 198888578 a 198890883).

Dado ao narrado, propõem a presente demanda, pugnando pela **concessão**, *inaudita altera parte,* de **tutela provisória de urgência** para compelir a ré a arcar, imediatamente, com os custos do tratamento prescrito pela médica assistente, com o medicamento **LEUPRORRELINA 3,75MG, IM**, a cada 28 dias, "*preferencialmente em ambiente hospitalar, ante a necessidade de alguém com expertise nesse tipo de aplicação, não sendo recomendável ser ministrado por qualquer pessoa*", especificamente no Complexo Hospitalar Unimed Recife (CHUR).

No mérito, além da confirmação da tutela de urgência, requerem o ressarcimento dos valores gastos com o tratamento e indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, atribuem à causa o valor de R$ 13.848,60.

A inicial veio instruída com os documentos de ID's 198888541 a 198890889, dentre os quais se destacam os laudos médicos (ID 198888573 e 198888574), laudos de idade óssea (ID 198888575 e 198888576), negativa da Unimed (ID 198888577) e notas fiscais da aquisição dos medicamentos (ID's 198888578 a 198890883).

Decisão interlocutória de ID 199093790: (i) concedeu a gratuidade judiciária às autoras; (ii) deferiu a prioridade de tramitação; (iii) indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A ré contestou alegando, preliminarmente, impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legitimidade da recusa, argumentando que o medicamento é de uso domiciliar e está expressamente excluído da cobertura obrigatória conforme Lei nº 9.656/98 e normativas da ANS. Sustentou a ausência de ato ilícito e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em réplica, as autoras refutaram os argumentos defensivos, insistindo na abusividade da negativa e na caracterização de danos morais in re ipsa.

Instadas sobre a produção de provas, a ré quedou-se inerte. O Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a analisar e decidir.

O presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015.

No que toca a **impugnação à gratuidade judiciária** verifica-se que não merece acolhida.

Isso porque se trata o autor de pessoa menor de idade, de modo que o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.

Enfim, conforme jurisprudência do STJ em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação, não se afigurando adequado e correto a alegação de que de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores. Neste sentido:

> PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE.
> 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.
> 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal.
> 3. **O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.**
> **4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.**
> **5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.** Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.7. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de **23/6/2023**.)

Neste contexto, **rejeito a impugnação à gratuidade.**

No caso em tela, a controvérsia reside na obrigatoriedade ou não do plano de saúde réu em fornecer o medicamento **LEUPRORRELINA 3,75MG** para tratamento de Puberdade Precoce Central das autoras.

Impende destacar que os contratos de plano de saúde, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

É incontroverso que as autoras são beneficiárias do plano de saúde operado pela ré, encontrando-se adimplentes com suas obrigações contratuais. Também restou demonstrado o diagnóstico de Puberdade Precoce Central e a prescrição médica do medicamento em questão, com aplicação por profissional habilitado.

A controvérsia reside na interpretação das cláusulas contratuais e da legislação aplicável no tocante à exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp 1.692.938/SP e 1.883.654/SP, especificamente tratando da obrigação de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, reconheceu ser "*lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim*", sendo esta, conforme explanado pelos julgadores, a melhor interpretação dos arts. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, inc. VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, inc. VI, da RN nº 465/2021).

O STJ reiterou este posicionamento em várias decisões recentes, dentre as quais destaco as seguintes:

"*É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos*

orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes." (AgInt no REsp n. 2.161.273/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de **27/2/2025**)

"*A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, <u>não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar</u>, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998*." (REsp n. 2.071.955/RS, Terceira Turma, DJe de **7/3/2024**)

Outrossim, em julgado recente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), em demanda semelhante, também objetivando o fornecimento do medicamento LEUPRORRELINA, <u>entendeu não ser o fármaco de cobertura obrigatória pelo plano de saúde</u>. Vejamos:

EMENTA: **APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEUPRORRELINA** E NORDITROPIN. EXCLUSÃO CONTRATUAL. **MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA**. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts . 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692 .938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)." (AgInt no REsp n. 2 .026.468/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). 2. **Considerando que o medicamento não foi prescrito como sendo essencial para manutenção da vida do paciente e tratando-se de limitação/exclusão contratual autorizadas por Lei, não se verifica a abusividade da negativa**. (TJ-PE - Apelação Cível: 00019492320228173370, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: **21/06/2024**, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)

Segundo a petição inicial, o direito perseguido pela parte autora resta evidenciado nos autos, uma vez que "*o tratamento deve ser ministrado por profissional habilitado, porque o medicamento deve ser aplicado por injeção intramuscular*", transcrevendo apenas os seguintes trechos da ementa do AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ:

"*AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.* ***PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA.*** *REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA.* ***MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO****. HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.*

(…)

5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)"

Pois bem, ao que se depreende do trecho supra transcrito da ementa, a medicação objeto do citado julgado do STJ foi prescrita em situação de home care, o que não se observa no caso das autoras. Segue o que consta no item 6 da referida ementa:

"(…) *6.* ***Na hipótese, a autora encontrava-se em <u>home care, atenção à saúde concedida em substituição à internação hospitalar,</u>*** *de modo que* ***a medicação prescrita nesse <u>estado de internação</u>****, mesmo sendo uma "solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", mas, ao contrário,* ***é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida)***" (Sem destaque no original).

Note-se que, embora a inicial pugne pelo <u>fornecimento do tratamento em unidade hospitalar</u>, **tal determinação não consta nos laudos médicos que lastreiam a presente demanda (**IDs 198888573 e 198888574), os quais, neste ponto, apenas consignam que "*a aplicação deve ser realizada por profissional habilitado*", e não há qualquer indicação de que a aplicação do medicamento deve ser feita em hospital, ou que fármaco é de uso exclusivo hospitalar.

Assim, diante do panorama fático descortinado, com esteio na própria prova colacionada aos autos pela parte autora, constata-se que em se tratando de <u>medicamentos ministrados fora do regime de internação hospitalar ou ambulatorial, não versando sobre tratamento de neoplasia ou quimioterapia oncológica, a exclusão de cobertura encontra suporte no art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98:</u>

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigência mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**:

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

Para além disto, preconiza a Resolução Normativa 465/2021 da ANS:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Neste ser assim, há cobertura para medicamentos de uso domiciliar apenas no que tange a quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento de câncer (inciso IX), bem como medicamentos antineoplásicos orais, como dispõe o inciso X, ambos do art. 18, da RN em relevo.

Deste modo, à luz desses dispositivos normativos, depreende-se que é lícita a exclusão de medicação para tratamento domiciliar convencional, já que a obrigatoriedade de fornecimento pelos planos de saúde externamente à unidade de saúde está restrita aos medicamentos antineoplásicos/quimioterápicos em tratamento oncológico.

Assim, a recusa pelo plano de saúde de custeio de medicamento para fins de tratamento terapêutico, não configura abusividade, até porque o medicamento receitado para o caso concreto não é serviço essencial à natureza do contrato de assistência à saúde, cuidando-se, em real verdade, de serviço excepcional, adicional.

Deste modo, não tendo o plano de saúde a obrigação de fornecer os medicamentos vindicados, não há como acolher os pedidos de obrigação de fazer e nem em danos morais, já que não há conduta ilícita ou irregular praticada pela parte ré.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão atrial, ao tempo que **extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.**

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em sintonia com o art. 85, § 2º do CPC/2015, cujo exigibilidade encontra-se suspensa em face do benefício da justiça gratuita deferida à parte autora na decisão inaugural.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Intime-se, também, o Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 16 de julho de 2025.

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
16/07/2025 12:38:20
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 209906368

25071612382005000000204394380

IMPRIMIR GERAR PDF